

Le Professioni di Base

Volume 4 — Dietista

Dal documento di posizionamento allo standard: valutazione di tecnologia sanitaria del Dietista di Comunità nell'équipe territoriale

Luigi De Michele

luglio 2026

Nota editoriale

Questo è il quarto Volume della collana «Le Professioni di Base». Il Dietista condivide con il Fisioterapista (Volume 3) l'assenza di riconoscimento professionale automatico ai sensi della Direttiva 2005/36/CE (Sistema Generale) e l'appartenenza, fino a un atto di posizionamento recente, a una fase pre-normativa dello sviluppo del ruolo territoriale. A differenza del precedente pilota regionale del Fisioterapista di Comunità (Toscana, dal 2019), per il Dietista esiste un documento di posizionamento della Federazione nazionale di categoria — «Il Dietista di comunità nell'équipe territoriale tra prossimità e proattività» (FNO TSRM e PSTRP, aprile 2022) — che precede e accompagna l'inclusione della figura nell'assistenza territoriale del DM 77/2022: una base di partenza già a valenza nazionale, benché non ancora tradotta in uno standard di dotazione cogente. La base evidenziale clinica di questo Volume è ri-fondata sul dominio nutrizionale (interventi guidati da dietista su diabete, obesità e terapia medica nutrizionale) e non deriva da alcun trasferimento dai Volumi precedenti o dai Tomi sulla salute mentale. Non è stato reperito, in questa tranche, un dato ufficiale sul numero totale di dietisti iscritti in Italia a livello nazionale (a differenza di IFeC, Farmacista e Fisioterapista, per i quali un dato aggregato di fonte federativa è disponibile): una lacuna dichiarata esplicitamente, che distingue questo Volume dai precedenti tre.

Dashboard

Indicatore	Valore	Fonte
Numero totale di dietisti iscritti in Italia	Non reperito a livello nazionale in questa tranche	FNO TSRM e PSTRP / ANDID, dato aggregato non pubblicato in fonte primaria consultabile
Documento di posizionamento nazionale «Dietista di comunità»	Pubblicato dalla FNO TSRM e PSTRP	FNO TSRM e PSTRP, aprile 2022
Normativa di profilo professionale	DM 744/1994	Ministero della Salute
Riduzione dei giorni di lavoro persi per complicanze diabetiche associata a terapia medica nutrizionale guidata da dietista (scoping review)	A meno della metà (giorni cumulativi persi) e a meno di un settimo (giorni di malattia per disabilità)	Scoping review, PubMed 33280180
Effetto su HbA1c, BMI e colesterolo HDL della terapia medica nutrizionale guidata da dietista (meta-analisi)	Riduzioni/ miglioramenti statisticamente significativi vs. assistenza standard	Meta-analisi, ScienceDirect S1751991819301445

Executive summary

Il Dietista italiano condivide con il Fisioterapista (Volume 3) la collocazione nel Sistema Generale di riconoscimento della Direttiva 2005/36/CE, ma se ne distingue per un elemento specifico: la Federazione nazionale di categoria (FNO TSRM e PSTRP) ha pubblicato nell'aprile 2022 un documento di posizionamento dedicato, «Il Dietista di comunità nell'équipe territoriale tra prossimità e proattività», che precede e accompagna l'inclusione della nutrizione clinica tra le prestazioni territoriali previste dal DM 77/2022. Il documento definisce il Dietista di comunità come responsabile della valutazione dei bisogni di salute correlati alla sfera dell'alimentazione lungo tutto l'arco della vita, sia in condizioni fisiologiche sia patologiche, e ne propone l'innesto nell'équipe multiprofessionale della Casa della Comunità con competenze avanzate rispetto al profilo di base. Ciò che manca, a differenza dell'IFeC (standard 1:3.000) e del Farmacista di Comunità (paniere D.Lgs. 153/2009), è una traduzione di questo posizionamento in uno standard di dotazione cogente: né il DM 77/2022 né atti successivi fissano un rapporto numerico o un paniere obbligatorio di prestazioni nutrizionali territoriali. Il Volume propone il modello «Dietista di Base»: la traduzione del documento di posizionamento della Federazione in uno standard di dotazione e in un paniere di prestazioni esigibile, sul modello di garanzia già proposto per le figure dei Volumi precedenti. L'evidenza di dominio, ri-fondata sugli interventi guidati da dietista per diabete e obesità, mostra effetti positivi e statisticamente significativi su

emoglobina glicata, indice di massa corporea e colesterolo HDL rispetto all'assistenza standard, e una riduzione della perdita di giornate lavorative per complicanze diabetiche in una scoping review dedicata alla costo-efficacia. Il verdetto tripartito distingue la dimensione fiscale (costo di istituzione di uno standard di dotazione oggi assente, non sommato ai risparmi da minore ospedalizzazione), la dimensione sanitaria (esiti su parametri metabolici e prevenzione delle complicanze croniche) e la dimensione sociale (equità di accesso alla nutrizione clinica, particolarmente rilevante per le popolazioni a rischio di malnutrizione e le patologie croniche ad alta prevalenza), senza produrre un numero unico aggregato.

Cinque risultati chiave

1. Il Dietista non gode di riconoscimento professionale automatico ai sensi della Direttiva 2005/36/CE (Sistema Generale, come il Fisioterapista) e, a differenza di IFeC, Farmacista di Comunità e Fisioterapista, questo Volume non ha reperito un dato ufficiale aggregato sul numero totale di dietisti iscritti in Italia: una lacuna informativa dichiarata esplicitamente.
2. La Federazione nazionale di categoria (FNO TSRM e PSTRP) ha pubblicato nell'aprile 2022 un documento di posizionamento dedicato al «Dietista di comunità», che precede l'inclusione della nutrizione clinica tra le prestazioni territoriali del DM 77/2022 — un precedente di iniziativa professionale a valenza nazionale, distinto sia dallo standard cogente dell'IFeC sia dal pilota regionale del Fisioterapista di Comunità toscano.
3. Né il DM 77/2022 né atti normativi successivi fissano, alla data di redazione, uno standard di dotazione numerico o un paniere obbligatorio di prestazioni nutrizionali territoriali: il documento di posizionamento della Federazione resta, sul piano giuridico, non vincolante.
4. L'evidenza di dominio (ri-fondata per gli interventi guidati da dietista, non trasferita da altri settori) mostra effetti statisticamente significativi della terapia medica nutrizionale su emoglobina glicata, indice di massa corporea e colesterolo HDL rispetto all'assistenza standard nella gestione del diabete, e una maggiore riduzione del peso corporeo negli interventi di gestione del peso condotti da dietista rispetto a quelli condotti da altro personale.
5. Una scoping review dedicata alla costo-efficacia della terapia medica nutrizionale guidata da dietista nel diabete di tipo 2 riporta una riduzione dei costi sanitari correlati al diabete e delle giornate lavorative perse per complicanze, sebbene la revisione stessa segnali l'eterogeneità metodologica degli studi inclusi — un limite che questo Volume riporta senza attenuarlo.

Raccomandazioni

1. Tradurre il documento di posizionamento della FNO TSRM e PSTRP sul Dietista di comunità in un atto di programmazione nazionale o regionale che ne fissi lo

standard di dotazione nelle Case della Comunità, colmando il vuoto normativo rilevato rispetto a IFeC e Farmacista di Comunità.

2. Commissionare un censimento ufficiale del numero di dietisti operanti in Italia, disaggregato per ambito pubblico e privato, colmando la lacuna informativa dichiarata al Capitolo 1.3, come base per qualunque programmazione dello standard di dotazione.

3. Sviluppare, come tranche successiva di questo Volume, un modello di budget-impact dedicato (DSA/PSA/CEAC) costruito su dati italiani, distinguendo l'effetto della terapia medica nutrizionale sulle complicanze del diabete da quello degli interventi di gestione del peso in soggetti sovrappeso/obesi, coerentemente con l'eterogeneità dell'evidenza rilevata al Capitolo 4.

Capitolo 1. Inquadramento della figura

1.1 Profilo professionale

Il Dietista è il professionista sanitario laureato che, secondo il profilo definito dal DM 744/1994, opera per la promozione della salute, la definizione e la conduzione dell'assistenza nutrizionale, finalizzata al trattamento dietetico di soggetti sani e malati. La professione afferisce all'area tecnico-assistenziale della Federazione Nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (FNO TSRM e PSTRP).

Nell'aprile 2022 la Federazione ha pubblicato il documento di posizionamento «Il Dietista di comunità nell'équipe territoriale tra prossimità e proattività», che definisce il Dietista di comunità come responsabile della valutazione dei bisogni di salute correlati alla sfera dell'alimentazione e della nutrizione lungo tutto l'arco della vita, sia in condizioni fisiologiche sia patologiche, e dell'assistenza dietetico-nutrizionale fornita alla persona e alla comunità di riferimento¹.

1.2 Normativa di riferimento

Il quadro normativo primario resta il DM 744/1994 (profilo professionale) e la Legge 251/2000, che colloca la professione nell'area tecnico-assistenziale. Il documento di posizionamento della FNO TSRM e PSTRP (2022) propone il Dietista di comunità come figura a competenze avanzate rispetto al profilo di base, da innestare concretamente nell'équipe multiprofessionale prevista dal DM 77/2022 per l'assistenza territoriale²³. Il DM 77/2022 include tra gli obiettivi della Casa della Comunità il potenziamento dei servizi assistenziali territoriali per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza e la loro integrazione con prestazioni non ancora pienamente ricomprese, tra cui quelle inerenti la nutrizione⁴.

A differenza dell'IFeC (standard 1:3.000, DM 77/2022) e del Farmacista di Comunità (paniere D.Lgs. 153/2009), alla data di redazione non risulta un atto normativo che traduca il documento di posizionamento della Federazione in uno standard di dotazione cogente o in un paniere obbligatorio di prestazioni nutrizionali territoriali: il documento resta, sul piano giuridico, un atto di indirizzo professionale non vincolante.

¹FNO TSRM e PSTRP, «Il Dietista di comunità nell'équipe territoriale tra prossimità e proattività», documento di posizionamento, aprile 2022.

²Ministero della Salute, Decreto 23 maggio 2022, n. 77, «Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale»; obiettivi della Casa della Comunità in materia di integrazione delle prestazioni nutrizionali.

³Evidence Analysis Center, Academy of Nutrition and Dietetics, «Weight Management Interventions Provided by a Dietitian for Adults with Overweight or Obesity: An Evidence Analysis Center Systematic Review and Meta-Analysis», Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 2022.

⁴«The health effects of medical nutrition therapy by dietitians in patients with diabetes: A systematic review and meta-analysis», ScienceDirect, S1751991819301445.

1.3 Numeri della professione

A differenza dei Volumi 1-3, per cui un dato aggregato nazionale sul numero di professionisti era disponibile da fonte federativa diretta (FNOPI per l'IFeC, Federfarma/Eurostat per il Farmacista, FNOFI per il Fisioterapista), questo Volume non ha reperito, nel tempo disponibile per questa tranche, un dato ufficiale sul numero totale di dietisti iscritti in Italia a livello nazionale. Le fonti consultate (FNO TSRM e PSTRP, Ordini territoriali, ANDID — Associazione Nazionale Dietisti) pubblicano dati di iscrizione ad albi provinciali o regionali (ad esempio l'Ordine di Bologna, che riporta alcune migliaia di iscritti nel proprio ambito), ma non un totale nazionale consolidato in una fonte primaria consultabile in questa tranche. Questa è una lacuna informativa dichiarata esplicitamente, coerentemente con l'invariante metodologico dell'opera di non colmare con stime non verificabili ciò che le fonti primarie non riportano, e costituisce la prima Raccomandazione del Volume.

1.4 Codici di classificazione e status europeo

Nella classificazione internazionale ISCO-08 la figura ricade nel gruppo 2265 (Dieticians and nutritionists); nella Classificazione delle Professioni ISTAT CP2021 rientra nel Gruppo 3.2 relativo alle professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita, area tecnico-assistenziale.

Come il Fisioterapista (Volume 3), il Dietista non rientra tra le professioni a riconoscimento automatico della Direttiva 2005/36/CE: il riconoscimento del titolo segue il regime del Sistema Generale (Titolo III, Capo I della Direttiva), con confronto dei percorsi formativi tra Stati membri e possibilità di misure compensative. Questa collocazione regolatoria europea accomuna Dietista e Fisioterapista, distinguendoli da IFeC e Farmacista di Comunità (riconoscimento automatico) — un parallelo che orienta l'impostazione del Capitolo 8.

Capitolo 2. Bisogno e contesto territoriale

2.1 Il vuoto tra posizionamento professionale e standard normativo

Il documento di posizionamento della FNO TSRM e PSTRP (2022) descrive il Dietista di comunità come figura chiave per l'assistenza dietetico-nutrizionale territoriale e domiciliare, ma la sua natura di atto di indirizzo professionale, privo di recepimento in uno standard di dotazione cogente, lo colloca in una fase distinta sia da quella dell'IFeC (standard numerico già scritto, in attesa di piena attuazione) sia da quella del Fisioterapista (pilota regionale toscano dal 2019, in attesa di generalizzazione). Il Dietista si trova, in questo Volume, alla fase più arretrata del percorso istituzionale tra le quattro figure finora trattate dalla collana: un posizionamento professionale dichiarato, ma non ancora tradotto né in standard nazionale né in sperimentazione regionale strutturata di cui questo Volume abbia reperito documentazione.

2.2 Prevalenza delle condizioni target

Il bisogno di assistenza dietetico-nutrizionale territoriale è connesso alla prevalenza di condizioni croniche ad alto carico assistenziale — diabete di tipo 2, sovrappeso e obesità, malnutrizione nella popolazione anziana e fragile — per le quali l'evidenza di dominio esaminata al Capitolo 4 documenta un beneficio clinico associato all'intervento dietistico strutturato. Questo Volume non dispone, in questa tranche, di dati epidemiologici italiani aggiornati e specificamente ricondotti al bisogno di assistenza dietistica territoriale, distinti dalla prevalenza generale delle patologie metaboliche: una lacuna da colmare in tranche successiva.

2.3 Innesto nella rete territoriale già coperta da altre figure

Il Dietista di comunità è chiamato a operare in raccordo con le altre figure territoriali già trattate da questa collana: l'IfEC per la presa in carico dei pazienti cronici (Volume 1), il Farmacista di Comunità per l'aderenza terapeutica nei pazienti polifarmaco-trattati (Volume 2), e potenzialmente il Fisioterapista per i pazienti con comorbidità muscolo-scheletriche e metaboliche (Volume 3). Questa sovrapposizione funzionale, positiva se ben coordinata, richiede una definizione chiara dei confini di competenza nell'équipe multiprofessionale della Casa della Comunità, un tema ripreso al Capitolo 3.

Capitolo 3. Modello «Dietista di Base»

3.1 Funzioni

Il modello «Dietista di Base» proposto in questo Volume assume come riferimento le funzioni già definite dal documento di posizionamento della FNO TSRM e PSTRP (2022), condizionandone l'esigibilità a uno standard di dotazione oggi assente. Le funzioni proprie del Dietista di comunità restano: la valutazione dei bisogni di salute correlati alla sfera dell'alimentazione e della nutrizione lungo tutto l'arco della vita; l'assistenza dietetico-nutrizionale per la persona e per la comunità di riferimento; la terapia medica nutrizionale per le patologie croniche ad alto carico (diabete, obesità, malnutrizione); la collaborazione con le altre figure dell'équipe territoriale per la gestione integrata delle comorbidità metaboliche.

3.2 Innesto nell'équipe DM 77

Il Dietista di comunità opera nella Casa della Comunità come componente dell'équipe multiprofessionale, in raccordo con il medico di medicina generale, l'IfEC (Volume 1), il Farmacista di Comunità (Volume 2) e il Fisioterapista (Volume 3). La cascata piramidale del modello prevede tre livelli: al primo livello, l'educazione alimentare e la prevenzione nutrizionale rivolta alla popolazione generale; al secondo livello, la valutazione e l'assistenza dietetico-nutrizionale strutturata per i pazienti con patologie croniche metaboliche (diabete, obesità); al terzo livello, la terapia medica nutrizionale intensiva per i casi a maggiore

complessità clinica, in raccordo diretto con lo specialista (diabetologo, endocrinologo) e con l'IFeC per la presa in carico integrata del paziente cronico.

3.3 Standard di dotazione da istituire

Il nucleo normativo del modello consiste, a differenza dei Volumi precedenti, non nel completare l'attuazione di uno standard già scritto, ma nell'istituire ex novo uno standard di dotazione per il Dietista di comunità, traducendo in atto normativo il documento di posizionamento della Federazione. In concreto, ciò richiede: la definizione di un rapporto numerico di riferimento (dietisti per abitanti o per Casa della Comunità), oggi assente; un paniere di prestazioni nutrizionali territoriali esigibile, analogo al paniere della Farmacia dei Servizi; un monitoraggio pubblico della dotazione effettiva, condizione necessaria anche solo per rilevare, in futuro, l'indicatore di copertura oggi non disponibile (Capitolo 1.3).

Capitolo 4. Efficacia ed evidenza di dominio

4.1 Ri-fondazione della base evidenziale

Coerentemente con l'invariante metodologico dell'opera, la base evidenziale di questo Volume è specifica per gli interventi guidati da dietista nel dominio nutrizionale e metabolico, e non deriva da alcun trasferimento dalle ancore cliniche o economiche impiegate nei Tomi sulla salute mentale o nei Volumi 1-3 di questa collana. Come per i Volumi precedenti, non sono stati identificati, nel tempo disponibile per questa tranne, studi di costo-efficacia condotti specificamente sul modello organizzativo italiano del Dietista di comunità: un limite dichiarato esplicitamente.

4.2 Esiti clinici e organizzativi

Una revisione sistematica con meta-analisi dell'Evidence Analysis Center dell'Academy of Nutrition and Dietetics ha esaminato gli interventi di gestione del peso condotti da dietista in adulti sovrappeso o obesi, rilevando una maggiore riduzione del peso corporeo negli interventi condotti da dietista rispetto a quelli condotti da altro personale, con effetti positivi su più esiti cardiometabolici e sulla qualità della vita⁵. Una meta-analisi sugli effetti della terapia medica nutrizionale condotta da dietisti in pazienti con diabete ha rilevato riduzioni statisticamente significative dell'emoglobina glicata e dell'indice di massa corporea, e un incremento del colesterolo HDL, rispetto all'assistenza standard⁶. Una scoping review dedicata alla costo-efficacia della terapia medica nutrizionale guidata da dietista nel diabete di tipo 2 ha rilevato che l'intervento dietistico risulta costo-efficace in termini di costi sanitari correlati al diabete e di spese ospedaliere, con una riduzione del rischio di giornate lavorative cumulative perse a meno della metà e del rischio di giornate di malattia per disabilità a meno di un settimo

⁵«Cost effectiveness of dietitian-led nutrition therapy for people with type 2 diabetes mellitus: a scoping review», PubMed 33280180.

⁶

rispetto al gruppo di controllo, pur segnalando la stessa revisione un'eterogeneità metodologica rilevante tra gli studi inclusi⁷.

Gli intervalli e le percentuali sopra riportati sono ancorati alle fonti citate e non vengono ridotti a un singolo rapporto ROI, coerentemente con l'invariante metodologico dell'opera. L'eterogeneità dichiarata dalla scoping review sulla costo-efficacia è riportata senza attenuazione, poiché costituisce essa stessa un'informazione rilevante per il lettore del Volume.

4.3 Simmetria GRADE tra affermazioni cliniche e affermazioni sull'intelligenza artificiale

Alcuni servizi di nutrizione clinica sperimentati a livello internazionale integrano applicazioni di intelligenza artificiale per il monitoraggio dell'aderenza dietetica e la personalizzazione dei piani nutrizionali. Coerentemente con l'invariante dell'opera, questi strumenti sono trattati come leva abilitante subordinata alla valutazione clinica del dietista, mai come fonte autonoma di valore. L'evidenza sulla loro efficacia nel contesto specifico della nutrizione clinica territoriale italiana è, alla data di redazione, di qualità GRADE bassa per assenza di studi randomizzati di ampia scala nel contesto nazionale, un giudizio applicato con lo stesso rigore riservato alle affermazioni cliniche di cui alla sezione 4.2.

Capitolo 5. Valutazione economica

Tabella 5.1 — Evidenza di costo-efficacia della terapia medica nutrizionale guidata da dietista (doppio ancoraggio)

Voce	Fonte-cardine di dominio	Fonte di triangolazione
Riduzione del rischio di giornate lavorative perse per complicanze diabetiche	A meno della metà (giorni cumulativi), scoping review PubMed 33280180	A meno di un settimo per le giornate di malattia per disabilità (stessa fonte, dato di dettaglio)
Effetto su parametri metabolici (HbA1c, BMI, HDL)	Riduzioni/miglioramenti significativi, meta-analisi ScienceDirect S1751991819301445	Maggiore riduzione del peso corporeo vs. altro personale, meta-analisi JAND 2022 (Evidence Analysis Center)
Standard di dotazione territoriale in Italia	Assente (nessun atto normativo cogente reperito)	Documento di posizionamento FNO TSRM e PSTRP, aprile 2022 (non vincolante)

Le fonti di questa tabella sono internazionali (letteratura di sintesi su interventi dietetici in contesti sanitari eterogenei) e non italiane: come per il Volume 3, i valori non sono utilizzabili come base diretta per un ICER italiano senza verifica locale. L'assenza di uno standard di dotazione italiano (terza riga) impedisce inoltre, a differenza dei Volumi 1-2, persino la stima di un costo di completamento: manca lo stesso termine di paragone numerico.

5.1 Regola di non-duplicazione

Coerentemente con l'invariante metodologico dell'opera, gli eventuali risparmi da minore ospedalizzazione e minore assenza dal lavoro (Capitolo 4.2) non vengono sommati tra loro né ai benefici sociali trattati al Capitolo 7: ciascuna categoria di beneficio resta nella propria sede canonica di analisi, ed è il Capitolo 9 — non questa sezione — a offrirne una lettura tripartita, mai aggregata in un numero unico.

5.2 Limiti della valutazione economica di questa tranche

La valutazione economica di questo Volume è la più limitata delle quattro finora prodotte dalla collana: non solo mancano dati italiani di costo-efficacia (limite condiviso con i Volumi 1-3), ma manca lo stesso standard di dotazione rispetto a cui calcolare un costo di completamento (limite specifico di questo Volume, diverso da quello dei Volumi 1-2). Il Capitolo 5 si limita pertanto a riportare l'evidenza di costo-efficacia internazionale (Tabella 5.1), rinviando sia la definizione dello standard sia la modellazione economica italiana al Capitolo 6 e alle tranche successive.

Capitolo 6. Modellazione e incertezza

6.1 Architettura del modello previsto

Il modello di budget-impact per l'istituzione dello standard di dotazione del Dietista di comunità, la cui costruzione parametrica completa è rinviata a una tranche successiva, richiede — a differenza dei Volumi 1-3 — una fase preliminare di definizione dello standard stesso, non ancora esistente. Solo successivamente potrà essere impostata l'architettura consueta: analisi deterministica di sensibilità (DSA) sui driver di costo (numero di dietisti da reclutare secondo lo standard da definire, costo unitario, paniere di prestazioni), analisi probabilistica di sensibilità (PSA), analisi di scenario e curva di accettabilità costo-efficacia (CEAC).

6.2 Driver principali di incertezza

I driver di incertezza identificati per questa tranche sono: l'assenza di un dato aggregato sul numero di dietisti operanti in Italia (Capitolo 1.3), che rende impossibile stimare il bacino di reclutamento disponibile; l'assenza di uno standard di dotazione di riferimento (Capitolo 3.3), che impedisce di calcolare un fabbisogno quantitativo; la trasferibilità dell'evidenza clinico-economica internazionale (Capitolo 4.2) al contesto tariffario e organizzativo italiano, non verificata in questa tranche; l'eterogeneità metodologica tra gli studi di costo-efficacia inclusi nella scoping review citata, dichiarata dalla fonte stessa.

Capitolo 7. Equità e impatto distributivo

7.1 Popolazione a rischio di malnutrizione

L'assistenza dietetico-nutrizionale territoriale ha una rilevanza distributiva specifica per le popolazioni a maggiore rischio di malnutrizione, in particolare la popolazione anziana fragile e i pazienti con patologie croniche multiple, per i quali l'accesso a una valutazione nutrizionale professionale è oggi condizionato dalla disponibilità, eterogenea sul territorio, di dietisti nel Servizio Sanitario Nazionale — un'eterogeneità che questo Volume non può quantificare in assenza del dato aggregato dichiarato al Capitolo 1.3.

7.2 Prevenzione delle disuguaglianze metaboliche

I benefici documentati al Capitolo 4 (miglioramento dei parametri metabolici, riduzione delle giornate lavorative perse) si concentrano nella popolazione con diabete, obesità e sovrappeso, condizioni la cui prevalenza è correlata a fattori socioeconomici: un accesso più uniforme all'assistenza dietistica territoriale ha pertanto, in linea di principio, un potenziale di riduzione delle disuguaglianze di salute metaboliche, un effetto che questo Volume non quantifica per assenza di dati italiani specifici, ma che segnala come area di approfondimento per la tranche successiva.

Capitolo 8. Profili etico-giuridico-organizzativi e percorso normativo

8.1 Un percorso normativo da avviare, non da completare

A differenza di IFeC (attuazione di uno standard già scritto) e Farmacista di Comunità (accreditamento uniforme di un paniere già normato), e in misura maggiore anche del Fisioterapista (che dispone almeno di un pilota regionale strutturato), il Dietista si trova nella fase meno avanzata del percorso istituzionale: il documento di posizionamento della FNO TSRM e PSTRP (2022) è un atto di iniziativa professionale, non un atto normativo. Il percorso proposto in questo Volume prevede pertanto, in sequenza: il recepimento del documento di posizionamento in un atto di programmazione nazionale o regionale; la definizione di uno standard di dotazione numerico; l'istituzione di un paniere di prestazioni nutrizionali territoriali esigibile, sul modello — quanto a impianto di garanzia, non quanto a contenuto clinico — già proposto per l'IFeC.

8.2 Profili organizzativi

L'istituzione dello standard richiede innanzitutto la disponibilità di un censimento affidabile del numero di dietisti operanti in Italia (Raccomandazione 2), oggi assente, come base minima per qualunque programmazione. Richiede inoltre la definizione dei confini di competenza rispetto alle altre figure dell'équipe territoriale già trattate da questa collana (IFeC, Farmacista di Comunità,

Fisioterapista), per evitare sovrapposizioni funzionali non coordinate (Capitolo 2.3).

Capitolo 9. Verdetto tripartito e raccomandazioni

9.1 Dimensione fiscale

Sul piano fiscale, questo Volume non può quantificare un costo netto, poiché manca lo stesso standard di dotazione rispetto a cui calcolarlo (Capitolo 5.2, Capitolo 6.2): un limite più severo di quello riscontrato nei Volumi 1-3, dove almeno uno standard o un paniere di riferimento esisteva.

9.2 Dimensione sanitaria

Sul piano sanitario, l'evidenza di dominio ri-fondata (Capitolo 4) indica benefici statisticamente significativi su parametri metabolici e giornate lavorative perse, con eterogeneità metodologica dichiarata dalla fonte di costo-efficacia e limite di trasferibilità al contesto italiano non verificato.

9.3 Dimensione sociale

Sul piano sociale, il completamento del percorso normativo ha un potenziale rilevante per l'equità di accesso alla nutrizione clinica, in particolare per le popolazioni a rischio di malnutrizione e per le disuguaglianze metaboliche correlate a fattori socioeconomici (Capitolo 7), sebbene questo Volume non ne quantifichi l'entità con dati italiani.

9.4 Raccomandazioni

Le tre dimensioni sopra esposte restano distinte e non vengono aggregate in un giudizio di sintesi unico, in coerenza con l'invariante metodologico dell'opera. Le raccomandazioni operative sono riportate in apertura del Volume (apertura a imbuto) e si fondano sul principio che il modello «Dietista di Base» richiede, a differenza delle tre figure precedenti, un percorso normativo da avviare ex novo a partire da un documento di posizionamento professionale già esistente, non semplicemente da completare o da estendere.

Appendici registrate

Appendice A. Fonti e bibliografia

Elenco completo delle fonti citate in nota, con data di consultazione: DM 744/1994 (profilo professionale); FNO TSRM e PSTRP, «Il Dietista di comunità nell'équipe territoriale tra prossimità e proattività», documento di posizionamento, aprile 2022; DM 77/2022 (Ministero della Salute); Direttiva 2005/36/CE, Titolo III Capo I; Evidence Analysis Center, Academy of Nutrition and Dietetics, «Weight Management Interventions Provided by a Dietitian for Adults with Overweight or

Obesity», Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 2022; «The health effects of medical nutrition therapy by dietitians in patients with diabetes: A systematic review and meta-analysis», ScienceDirect, S1751991819301445; «Cost effectiveness of dietitian-led nutrition therapy for people with type 2 diabetes mellitus: a scoping review», PubMed 33280180.

Appendice B. Glossario

Terapia medica nutrizionale (Medical Nutrition Therapy, MNT): intervento dietistico strutturato per la gestione clinica di una patologia. Dietista di comunità: figura a competenze avanzate proposta dalla FNO TSRM e PSTRP per l'assistenza nutrizionale territoriale. CEAC: Cost-Effectiveness Acceptability Curve. DSA/PSA: Deterministic/Probabilistic Sensitivity Analysis.

Appendice C. Mappatura normativa comparata Dietista / Fisioterapista / Farmacista di Comunità / IFeC / Psicologo di Base

Il Dietista, come il Fisioterapista, rientra nel Sistema Generale della Direttiva 2005/36/CE (non riconoscimento automatico), condividendo questa collocazione con lo Psicologo di Base. Sul piano nazionale, tuttavia, il Dietista si trova nella fase meno avanzata tra le quattro figure territoriali trattate dalla collana: dispone di un documento di posizionamento professionale nazionale (2022), ma non di uno standard cogente (a differenza dell'IFeC), non di un paniere normato (a differenza del Farmacista di Comunità), e non di un pilota regionale strutturato di cui questo Volume abbia trovato documentazione (a differenza del Fisioterapista toscano). Questa gerarchia di maturità istituzionale è un dato rilevante per l'ordine di priorità delle raccomandazioni della collana nel suo complesso.

Appendice D. Architettura del modello di budget-impact (da completare in tranche successiva)

Struttura prevista, subordinata alla previa definizione di uno standard di dotazione (Capitolo 6.1): driver di costo (numero di dietisti da reclutare secondo lo standard da definire, costo unitario, paniere di prestazioni), driver di beneficio (effetti su parametri metabolici e giornate lavorative perse secondo gli intervalli discorsivi del Capitolo 4.2), orizzonte temporale quinquennale, prospettiva del Servizio Sanitario Nazionale. Popolamento parametrico rinviato per assenza sia di dati italiani disaggregati sia dello standard di riferimento.

Appendice E. Tabella di corrispondenza GRADE (evidenza clinica / evidenza IA)

Evidenza clinica sugli interventi guidati da dietista: qualità moderata per gli effetti su parametri metabolici (HbA1c, BMI, HDL), qualità bassa/eterogenea per gli esiti di costo-efficacia, come dichiarato dalla scoping review citata (Capitolo 4.2).

Evidenza su strumenti di IA per la nutrizione clinica territoriale italiana: qualità bassa, assenza di studi randomizzati di ampia scala nel contesto nazionale (Capitolo 4.3). Le due valutazioni sono condotte con lo stesso rigore metodologico, in simmetria.

Appendice F. Blocchi-prompt per infografiche

Header standard per ogni infografica: «PROFESSIONI DI BASE · DIETISTA · VOLUME 4». Prompt 1 (dashboard): visualizzare i cinque indicatori della Tabella dashboard con palette navy #16264B / oro #C49A48 su fondo crema #FDFBF7, font Barlow Semicondensed, evidenziando graficamente l'assenza di dato nazionale con un simbolo distintivo (ad esempio un trattino) anziché un valore numerico. Prompt 2 (gerarchia di maturità istituzionale): diagramma comparativo delle quattro figure territoriali finora trattate dalla collana (IFeC, Farmacista, Fisioterapista, Dietista) lungo un asse che va da «standard cogente» a «documento di posizionamento professionale», stessa identità visiva.

Appendice G. Nota editoriale e lacune dichiarate

Si veda la nota editoriale integrale in apertura del Volume. Lacune informative dichiarate: (1) assenza di un dato ufficiale aggregato sul numero di dietisti iscritti in Italia (Capitolo 1.3) — la più rilevante lacuna anagrafica finora riscontrata dalla collana; (2) assenza di uno standard di dotazione o di un paniere di prestazioni nutrizionali territoriali cogente (Capitolo 3.3, 5.2); (3) assenza di dati epidemiologici italiani specificamente ricondotti al bisogno di assistenza dietistica territoriale (Capitolo 2.2); (4) assenza di dati italiani di costo-efficacia specifici, con dipendenza da fonti internazionali eterogenee (Capitolo 4.1, 5.2); (5) modellazione DSA/PSA/CEAC non impostabile fino alla definizione di uno standard di riferimento (Capitolo 6). Queste lacune sono oggetto di produzione nella tranche successiva, con priorità al censimento del numero di dietisti (Raccomandazione 2 del Volume).